CONSENTIMIENTO PARA SERVICIOS DE ANESTESIA

(CONSENT FOR ANESTHESIA SERVICES)

Saint Joseph's Hospital

Su médico ha consultado con Physician Specialists in Anesthesia, PC [Médicos Especialistas en Anestesia, Corporación Profesional] (de aquí en adelante nombrados PSA – un equipo independiente de médicos, enfermeras anestesistas, asistentes anestesistas, y enfermeras) para servicios de anestesia. Uno de nuestros médicos le hará una visita antes de que usted sea sometido a la intervención. No se olvide de hacer preguntas y manifestar sus inquietudes con respecto a la anestesia. Para proporcionar una programación flexible y permitir el uso eficiente de los quirófanos, PSA aplica el método de trabajo en equipo. Por ese motivo, es posible que el anestesiólogo que le visite por adelantado no sea el mismo anestesiólogo que vuelve a evaluarlo antes del procedimiento o que supervise su cuidado anestésico.

Servicios de anestesia son necesarios para permitir al cirujano efectuar la cirugía o procedimiento. Toda forma de anestesia tiene riesgos y no se pueden otorgar garantías ni promesas relacionadas a los resultados de su procedimiento o anestesia. No siempre es posible predecir cuál será la reacción y resultado de cada individuo. Efectos secundarios molestos tal como nausea, vómitos, dolor de garganta, dolor muscular o sueños pueden ocurrir en 10-20% de los casos, sin embargo, estos efectos secundarios rara vez son severos y se resuelven poco después de la cirugía. Aunque raramente surgen, existen lesiones potenciales posiblemente permanentes asociados con administración de anestesia o colocación del cuerpo para cirugía que incluyen pero no se limitan a: daño dental, lesión al ojo, ceguera, infección, hemorragia (sangrado excesivo) reacción a medicamento (incluye sarpullido, picazón, nausea, vómitos, shock y paro cardíaco/respiratorio), coágulos sanguíneos, entumecimiento, debilidad, parálisis, daño a órganos, infarto, derrame cerebral, daño a nervios, daño al cerebro, conocimiento bajo los efectos de la anestesia, atelectasia pulmonar (colapso del pulmón), retención de catéteres, y muerte. Estos riesgos se aplican a toda forma de anestesia y los riesgos específicos o adicionales que se identifiquen a continuación se puedan aplicar a un tipo específico de anestesia.

El tipo de anestesia elegido para su procedimiento dependerá de muchos factores tal como su condición física, la naturaleza de la intervención, la petición del cirujano y su propia preferencia. Su anestesiólogo hablará con usted para decidir cuál tipo de anestesia le convenga más. El Cuidado de Anestesia Monitoreado, Bloqueo Nervioso, Anestesia Espinal o Epidural pueden a veces requerir sedantes adicionales o administración de Anestesia General.

Anestesia General	**Resultado esperado** **Técnica**	Estado total inconsciente puede requerir colocación de un tubo en la garganta o tráquea. Droga inyectada dentro del torrente sanguíneo, inhalada a los pulmones, o por otras vías.
	Riesgos (incluyen pero no se limitan a)	Dolor de boca o garganta, ronquera, daño en la boca o dientes, conciencia durante la anestesia, daño a los vasos sanguíneos nausea, aspiración de vómito, pulmonía.
Bloqueo Espinal o Epidural • Anestesia quirúrgica • Analgesia postoperatorio	**Resultado esperado**	Disminución temporaria o pérdida de sensación y/o movimiento de la parte inferior del cuerpo. Reducción de dolor postoperatorio y como resultado, mejor recuperación.
	Técnica	Droga inyectada a través de una aguja/catéter ubicado ya sea directamente en el líquido del canal espinal o inmediatamente afuera del canal espinal. El catéter permanece para administrar medicamento para dolor.
	Riesgos (incluyen pero no se limitan a)	Dolor de cabeza, dolor de espalda, zumbido en los oídos, convulsiones, infección, debilidad persistente, adormecimiento, dolor residual, daño a los vasos sanguíneos o nervios, picazón, nausea, dolor irruptivo, dolor de espalda persistente, meningitis, parálisis, uso de otros métodos para aliviar dolor.
Bloqueo Nervioso incluyendo anestesia regional intravenosa • Surgical anesthesia • Postoperative analgesia	Resultado esperado	Pérdida temporaria de sensación y/o movimiento de una extremidad específica o área del cuerpo.
	Técnica	Anestesia local inyectada cerca de los nervios o en las venas del brazo mientra se usa un torniquete causando pérdida de sensación en el área sometido a la cirugía.
	Riesgos (incluyen pero no se limitan a)	Infección, convulsiones, debilidad, adormecimiento persistente, dolor residual que requiere anestesia adicional, daño a los nervios o vasos sanguíneos, fallo del bloqueo.
Cuidado de anestesia monitoreado	Resultado esperado	Reducción de ansiedad y dolor, amnesia parcial o total, control de signos vitales.
	Técnica	Droga inyectada dentro del torrente sanguíneo, inhalada a los pulmones, o por otras vías que produce un estado semiconsciente, disponibilidad del proveedor de anestesia.
	Riesgos (incluyen pero no se limitan a)	Un estado inconsciente, falta de aire, daño a los vasos sanguíneos, conocimiento de eventos quirúrgicos.
Catéteres Vasculares • Arteria Pulmonar • Venosa Central • Vía Arterial	Resultado esperado	Proveer acceso venoso/arterial para administrar líquidos/medicamentos, controlar función/presión cardíaca.
	Técnica	Colocar un catéter especial en una vena grande del cuello, hombro o ingle con o sin otro catéter que flota dentro del corazón, Catéter colocado en una arteria de la muñeca, ingle o brazo
	Riesgos (incluyen pero no se limitan a)	Infección, sangrado, perforación del pulmón que requiere una sonda pleural, repetición de colocación cuando el protocolo de enfermedad infecciosa lo requiere, daño al nervio, retención del alambre, arritmia, daño a los vasos sanguíneos.
Ecocardiographia Transesofágico	Resultado esperado	Examen o monitoreo de la función cardíaca y estructuras cardíacas por ultrasonido.
	Técnica	Colocación de una sonda especial en el esófago durante la cirugía.
	Riesgos (incluyen pero no se limitan a)	Daño esofágico, infección del pecho, daño a la boca o al laringe.

CONSENTIMIENTO: Por este medio, doy voluntariamente mi consentimiento a la administración de anestesia por parte de algún miembro de Physician Specialists in Anesthesia, P.C. quienes tienen credenciales para proveer servicios de anestesia en esta entidad de salud, así como todas las intervenciones relacionadas que sean necesarias o adecuadas. Doy mi autorización a PSA para presentar reclamaciones al seguro de salud y proveer los expedientes médicos necesarios para dicho propósito.

Certifico y reconozco que he tenido la oportunidad de leer este formulario, que entiendo los riesgos, alternativas y resultados esperados del servicio de anestesia y que he tenido suficiente tiempo para efectuar preguntas y considerar mi decisión.

X_____

Firma del paciente o la persona que firma en nombre del paciente *Patient signature or person signing on behalf of patient*	Fecha *Date*	Hora *Time*	**Patient Label**
X_____ Parentesco con el paciente (si fuera firmado por otra persona que no sea el paciente *Relationship to patient (if signed by person other than patient)*	Fecha *Date*	Hora *Time*	
X_____ Testigo *Witness*	Fecha *Date*	Hora *Time*	
X_____ Proveedor de Anestesia *Anesthesia Provider*	Fecha *Date*	Hora *Time*	MRFC Origin: 09/07/2011 MRC Revised: 04/19/2018 DIN: 110196-226